

b. Todas las afecciones nerviosas halladas en la familia del enfermo, sin tener en cuenta su frecuencia y su gravedad, se han aceptado para imputar a aquel una tara nerviosa hereditaria. ¿No es cierto que esta manera de ver parece contener una separación neta entre las familias indemnes de toda predisposición {*prédisposition*} nerviosa y las familias a ella sujetas sin límite ni restricción? ¿Y los hechos no abogan más bien en favor de la opinión opuesta, a saber, que existen transiciones y grados de disposición {*disposition*} nerviosa, y que ninguna familia escapa a ellos por completo?

c. Ciertamente, nuestra opinión sobre el papel etiológico de la herencia en las enfermedades nerviosas debe ser el resultado de un examen imparcial estadístico y no de una *petitio principii*. Mientras no se haya realizado ese examen, se debería creer tan posible la existencia de las neuropatías adquiridas como de las neuropatías hereditarias. Pero si puede haber neuropatías adquiridas por hombres no predispuestos, ya no se podrá negar que las afecciones halladas entre los ascendientes de nuestro enfermo acaso fueron, en parte, adquiridas. Así, ya no se podría invocarlas como pruebas concluyentes de la disposición hereditaria que se imputa al enfermo en razón de su historia familiar, puesto que rara vez se logra el diagnóstico retrospectivo de las enfermedades de los ascendientes o de los miembros ausentes de la familia.

d. Quienes han seguido a Fournier y a Erb con respecto al papel etiológico de la sífilis en la tabes dorsal y la parálisis progresiva han advertido que es preciso admitir influjos etiológicos poderosos cuya colaboración es indispensable para la patogenia de ciertas enfermedades que la herencia, por sí sola, no podría producir. Sin embargo, Charcot mantuvo hasta sus últimos días, como lo supe por una carta privada del maestro, una estricta oposición a la teoría de Fournier, que, no obstante, va ganando cada vez más terreno.

e. Es indudable que ciertas neuropatías pueden desarrollarse en el hombre perfectamente sano y de familia irreprochable. Es lo que se observa cotidianamente en el caso de la neurastenia de Beard; si la neurastenia se limitara a las personas predispuestas, nunca habría cobrado la importancia y la extensión que le conocemos.

f. En la patología nerviosa tenemos la herencia *similar* y la herencia llamada *disímil*. Respecto de la primera no se hallará nada más que decir; y aun es notabilísimo que en las afecciones que dependen de la herencia similar (enfermedad de Thomsen, enfermedad de Friedreich, miopatías, corea de Huntington, etc.) nunca se descubre huella alguna de otra influencia etiológica accesoria. Pero la herencia disí-

mil, mucho más importante que la otra, deja lagunas que sería preciso llenar para obtener una solución satisfactoria de los problemas etiológicos. Aquella consiste en el hecho de que los miembros de la familia se muestran afectados por las neuropatías más diversas, funcionales y orgánicas, sin que se pueda dilucidar una ley que dirija la sustitución de una enfermedad por otra ni el orden de su sucesión a través de las generaciones. Junto a individuos enfermos hay en esas familias personas que permanecen sanas, y la teoría de la herencia disímil no nos dice por qué cierta persona soporta la carga hereditaria sin sucumbir a ella, ni por qué otra persona enferma elegiría, entre las afecciones que constituyen la gran familia neuropática, tal afección nerviosa en lugar de otra —la histeria en lugar de la epilepsia, de la vesania, etc.—. Pero como lo fortuito no existe en patogenia nerviosa más que en otros campos, es preciso conceder que no es la herencia la que preside la elección de la neuropatía que se desarrollará en el miembro de una familia predispuesta, sino que cabe suponer la existencia de otros influjos etiológicos de naturaleza menos comprensible,¹ que merecerían entonces el nombre de *etiología específica* de tal o cual afección nerviosa. Sin la existencia de ese factor etiológico especial, la herencia no habría podido nada; se habría prestado a la producción de una neuropatía diversa si la etiología específica en cuestión hubiera sido remplazada por un influjo diverso.

II

Se han investigado poquísimas esas causas específicas y determinantes de las neuropatías, pues la atención de los médicos permaneció subyugada por la grandiosa perspectiva de la condición etiológica hereditaria.

No obstante, ellas merecen que se las haga objeto de un estudio asiduo; aunque su potencia patógena sólo sea, en general, accesoria respecto de la herencia, posee un gran interés práctico el conocimiento de esta etiología, que dará acceso a nuestro trabajo terapéutico, mientras que la predisposición hereditaria, fijada de antemano para el enfer-

¹ [En la publicación original de 1896 se lee «*compréhensible*»; en todas las reimpressiones posteriores, hasta la de 1925 inclusive, aparece «*incompréhensible*», pero en la de 1952 se vuelve al término primitivo. Cf. mi «Nota introductoria» a «Obsesiones y fobias» (1895c), *supra*, págs. 72-3.]

mo desde su nacimiento, opone un obstáculo inabordable a nuestros esfuerzos.²

Estoy empeñado desde hace años en la investigación de la etiología de las *grandes neurosis* (estados nerviosos funcionales análogos a la histeria), y precisamente sobre el resultado de esos estudios he de informar en las páginas que siguen. Para evitar todo posible malentendido, expondré primero dos puntualizaciones sobre la nosografía de las neurosis y sobre la etiología de las neurosis en general.

Me fue preciso dar comienzo a mi trabajo con una innovación nosográfica. He hallado razones para situar, junto a la histeria, la neurosis de obsesiones (*Zwangsneurose*) como afección autónoma e independiente, aunque la mayoría de los autores clasifican las obsesiones entre los síndromes constitutivos de la degeneración mental o las confunden con la neurastenia. Por mi parte, mediante el examen de su mecanismo psíquico había averiguado que las obsesiones están ligadas a la histeria más íntimamente de lo que se creería.

Histeria y neurosis de obsesiones forman el primer grupo de las grandes neurosis, que yo he estudiado. El segundo contiene la neurastenia de Beard, que yo he descompuesto en dos estados funcionales separados tanto por la etiología como por el aspecto sintomático: la *neurastenia* propiamente dicha y la *neurosis de angustia* (*Angstneurose*) —denominación que, dicho sea de paso, a mí mismo no me convence—. En un trabajo publicado en 1895³ he aducido en detalle las razones de esta separación, que creo necesaria.

En cuanto a la etiología de las neurosis, pienso que se debe reconocer en teoría que los influjos etiológicos, diferentes entre sí por su dignidad y modalidad de relación con el efecto que producen, pueden dividirse en tres clases:⁴ 1) *condiciones*, que son indispensables para que se produzca la afección respectiva, pero que son de naturaleza universal y se las encuentra de igual modo en la etiología de muchas otras afecciones; 2) *causas concurrentes*, que comparten el carácter de las condiciones en cuanto a funcionar en la causación de otras afecciones lo mismo que en la de la afección considerada, pero que no son indispensables para que esta última se produzca; 3) *causas específicas*, tan indispensables

² [En las ediciones anteriores a 1952, «interrumpe con su inabordable poder nuestros esfuerzos».]

³ [«Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de “neurosis de angustia”» (1895b).]

⁴ [Lo que sigue reproduce en gran parte, de manera bastante similar, las consideraciones hechas al final del segundo trabajo sobre la neurosis de angustia (1895f), *supra*, págs. 134-8.]

como las condiciones, pero de naturaleza estricta y que sólo aparecen en la etiología de la afección de la cual son específicas.

Y bien: en la patogénesis de las grandes neurosis la herencia cumple el papel de una *condición* poderosa en todos los casos y aun indispensable en la mayoría de ellos. Es cierto que no podría prescindir de la colaboración de las causas específicas, pero la importancia de la disposición hereditaria es demostrada por el hecho de que las mismas causas específicas no producirían ningún efecto patológico manifestado si actuaran sobre un individuo sano, mientras que en una persona predispuesta su acción hará estallar la neurosis, cuyo desarrollo e intensidad serán conformes al grado de esta condición hereditaria.

La acción de la herencia es entonces comparable a la del cable multiplicador en el circuito eléctrico, que exagera la desviación visible de la aguja, pero que no podría determinar su dirección.

En las relaciones que existen entre la condición hereditaria y las causas específicas de las neurosis cabe apuntar todavía otra cosa. La experiencia muestra —y se lo habría podido suponer de antemano— que en estas cuestiones de etiología no se deberían desdeñar las cantidades relativas, por así decir, de los influjos etiológicos. No se habría adivinado, en cambio, el hecho siguiente, que parece derivar de mis observaciones: que la herencia y las causas específicas pueden remplazarse mutuamente por el lado cuantitativo, que el mismo efecto patológico será producido por la concurrencia de una etiología específica muy grave con una disposición mediocre, o de una cargada herencia nerviosa con una influencia específica leve. Pero entonces no es sino un extremo muy verosímil de esta serie que hallemos también casos de neurosis donde en vano buscaríamos un grado apreciable de disposición hereditaria, toda vez que esa falta esté compensada por un potente influjo específico.

Como *causas concurrentes* o accesorias de las neurosis se pueden enumerar todos los agentes banales que hallamos en otros campos: emociones morales, agotamiento físico, enfermedades agudas, intoxicaciones, accidentes traumáticos, *surmenage* intelectual, etc. Sustento la tesis de que ninguno de ellos, ni siquiera el último, entra de manera regular o necesaria en la etiología de las neurosis, y sé bien que enunciar esta opinión es situarse en oposición directa a una teoría considerada universal e irreprochable. Desde que Beard hubo declarado a la neurastenia como el fruto de nuestra civilización moderna, no halló más que creyentes; pero a mí me

es imposible aceptar esta opinión. Un estudio laborioso de las neurosis me ha enseñado que la etiología específica de ellas se sustrajo al conocimiento de Beard.⁵

No pretendo despreciar la importancia etiológica de esos agentes banales. Ellos son muy variados, aparecen con frecuencia, e inculpadlos la mayoría de las veces por los propios enfermos, se vuelven más evidentes que las causas específicas de las neurosis, etiología esta que permanece escondida o ignorada. Asaz a menudo cumplen la función de agentes provocadores que tornan manifiesta la neurosis, latente hasta entonces, y poseen un interés práctico, porque la consideración de esas causas banales puede proporcionar unos puntos de apoyo para una terapia que no tenga como mira la curación radical y se conforme con hacer retroceder la afección a su estado anterior de latencia.

No se llega, sin embargo, a comprobar una relación constante y estrecha entre una de esas causas banales y tal o cual afección nerviosa; la emoción moral, por ejemplo, se encuentra tanto en la etiología de la histeria, de las obsesiones, de la neurastenia, como en la de la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la diabetes y otras muchas.

Las causas concurrentes banales podrán entonces reemplazar a la etiología específica por su proporción cuantitativa, pero nunca sustituirla por completo. Hay numerosos casos en que todos los influjos etiológicos están representados por la condición hereditaria y la causa específica, pues faltan las causas banales. En los otros casos, los factores etiológicos indispensables no bastan, por la cantidad que poseen, para hacer estallar la neurosis; así, puede mantenerse por largo tiempo un estado de salud aparente que es en verdad un estado de predisposición neurótica; si entonces una causa banal sobreagrega su acción, ello bastará para que la neurosis devenga manifiesta. Pero en tales circunstancias, nótese bien, será indiferente la naturaleza del agente banal que se agregue: emoción, trauma, enfermedad infecciosa u otro; el efecto patológico no se modificará con arreglo a esta variación, pues la naturaleza de la neurosis estará siempre dominada por la causa específica preexistente.

¿Cuáles son, pues, esas causas específicas de las neurosis? ¿Es una sola o hay varias? ¿Y se puede comprobar una relación etiológica constante entre tal causa y tal efecto

⁵ [Freud discutió este asunto más detenidamente diez años después, en «La moral sexual "cultural" y la nerviosidad moderna» (1908d), y, por supuesto, en muchos escritos posteriores.]

neurótico, de suerte que cada una de las grandes neurosis pueda ser reconducida a una etiología particular?

Me propongo sostener, apoyado en un examen laborioso de los hechos, que esta última suposición corresponde a la realidad, pues cada una de las grandes neurosis enumeradas tiene por causa inmediata una perturbación particular de la economía nerviosa, y estas modificaciones patológicas funcionales *reconocen como fuente común la vida sexual del individuo, sea un desorden de la vida sexual actual, sea unos acontecimientos importantes de la vida pasada.*

No es esta, a decir verdad, una proposición nueva, inaudita. Siempre se admitieron los desórdenes sexuales entre las causas de la nerviosidad, pero se los subordinaba a la herencia, se los coordinaba con otros agentes provocadores; su influjo etiológico fue restringido a un número limitado de los casos observados. Los médicos hasta habían adoptado el hábito de no investigarlos si el propio enfermo no los inculpaba. Los caracteres distintivos de mi manera de ver son que yo elevo esas influencias sexuales al rango de causas específicas, reconozco su acción en todos los casos de neurosis y, por último, descubro un paralelismo regular, prueba de una relación etiológica particular, entre la naturaleza del influjo sexual y la especie mórbida de la neurosis.

Estoy segurísimo de que esta teoría suscitará un huracán de contradicciones entre los médicos contemporáneos. Pero no es este el lugar para ofrecer los documentos y las experiencias que me han impuesto mi convicción, ni explicar el verdadero sentido de la expresión un poco vaga «desórdenes de la economía nerviosa». Lo haré, espero que con la mayor amplitud, en una obra que preparo sobre la materia.⁶ En el presente artículo me limito a enunciar mis resultados.

La neurastenia propiamente dicha, de aspecto clínico muy monótono una vez separada de ella la neurosis de angustia (fatiga, sensación de casco, dispepsia flatulenta, constipación, parestesias espinales, debilidad sexual, etc.), no reconoce otra etiología específica que el onanismo (inmoderado) o las poluciones espontáneas.

La acción prolongada e intensiva de esta satisfacción sexual perniciosa basta por sí misma para provocar la neurosis neurasténica o impone al sujeto el sello neurasténico especial manifestado más tarde bajo el influjo de una causa

⁶ [Cf. «Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa» (1896b), *infra*, págs. 163-4, n. 4.]

ocasional accesoria. He hallado también personas que presentaban los signos de la constitución neurasténica y en quienes no logré poner en evidencia la etiología mencionada, pero he comprobado al menos que en esos enfermos la función sexual nunca se había desarrollado hasta el nivel normal; parecían dotados, por herencia, de una constitución sexual análoga a la que es producida en el neurasténico a consecuencia del onanismo.⁷

La neurosis de angustia, cuyo cuadro clínico es mucho más rico (irritabilidad, estado de expectativa angustiada, fobias, ataques de angustia completos o rudimentarios, de terror, de vértigo, temblores, sudores, congestión, disnea, taquicardia, etc.; diarrea crónica, vértigo crónico de locomoción, hiperestesia, insomnio, etc.),⁸ se revela fácilmente como el efecto específico de diversos desórdenes de la vida sexual, que no carecen de un carácter común a todos ellos. La abstinencia forzosa, la irritación genital frustránea⁹ (que no es calmada por el acto sexual), el coito imperfecto o interrumpido (que no culmina en el goce), los esfuerzos sexuales que sobrepasan la capacidad psíquica del sujeto, etc., todos esos agentes, que son de una ocurrencia asaz frecuente en la vida moderna, parecen coincidir en esto: perturban el equilibrio de las funciones psíquicas y somáticas en los actos sexuales, e impiden la participación psíquica necesaria para que la economía nerviosa se libere de la tensión genésica.

Estas puntualizaciones, que acaso contengan el germen de una explicación teórica del mecanismo funcional de la neurosis en cuestión, dejan suponer ya que una exposición completa y verdaderamente científica de esta materia no es posible en la actualidad, y que sería preciso ante todo abordar el problema fisiológico de la vida sexual bajo un punto de vista nuevo.

Concluiré diciendo que la patogénesis de la neurastenia y de la neurosis de angustia puede muy bien prescindir de la cooperación de una disposición hereditaria. Es el resultado de la observación de todos los días; pero si la herencia está presente, el desarrollo de la neurosis sufrirá su influencia formidable.

⁷ [Se hallará un examen más amplio de la masturbación en «La sexualidad en la etiología de las neurosis» (1898a), *infra*, pág. 267.]

⁸ Sobre la sintomatología y la etiología de la neurosis de angustia, véase mi trabajo antes citado [1895b].

⁹ [«Frustes» en el original. Cf. «Obsesiones y fobias» (1895c), *supra*, pág. 82, n. 11.]

Para la segunda clase de las grandes neurosis, histeria y neurosis de obsesiones, la solución de la cuestión etiológica es de una simplicidad y una uniformidad sorprendentes. Debo mis resultados al empleo de un nuevo método de psicoanálisis,¹⁰ al procedimiento de exploración de Josef Breuer, un poco sutil pero insustituible, tan fértil se ha mostrado para esclarecer las vías oscuras de la ideación inconciente. Por medio de este procedimiento —que no hemos de describir en este lugar—,¹¹ uno persigue los síntomas histéricos hasta su origen, que todas las veces halla en cierto acontecimiento de la vida sexual del sujeto, idóneo para producir una emoción penosa. Remontándome hacia atrás en el pasado del enfermo, paso a paso y dirigido siempre por el encadenamiento de los síntomas, de los recuerdos y de los pensamientos despertados, he llegado por fin al punto de partida del proceso patológico y no pude menos que ver que en todos los casos sometidos al análisis había en el fondo la misma cosa, la acción de un agente al que es preciso aceptar como causa específica de la histeria.

Sin duda se trata de un recuerdo que se refiere a la vida sexual, pero que ofrece dos caracteres de la mayor importancia. El acontecimiento del cual el sujeto ha guardado el recuerdo inconciente es una *experiencia precoz de relaciones sexuales con irritación efectiva de las partes genitales, resultante de un abuso sexual practicado por otra persona*, y el *período de la vida* que encierra este acontecimiento funesto es la *niñez temprana* {*première jeunesse*}, hasta los ocho a diez años, antes que el niño llegue a la madurez sexual.¹²

Experiencia sexual pasiva antes de la pubertad: tal es, pues, la etiología específica de la histeria.

Agregaré sin demora algunos detalles de hecho y algunos comentarios al resultado enunciado, para combatir la desconfianza que espero encontrar. He podido practicar el psicoanálisis completo en trece casos de histeria, tres de los cuales eran genuinas combinaciones de histeria con neurosis de obsesiones (no digo: histeria *con* obsesiones). En ninguno de ellos faltaba el suceso caracterizado en el párrafo anterior; estaba representado por un atentado brutal cometido por una persona adulta, o por una seducción menos brusca y menos repelente pero que llevó al mismo fin. En siete casos

¹⁰ [Primera vez que apareció el término en una obra publicada; cf. «Las neuropsicosis de defensa» (1894a), *supra*, pág. 48, n. 6.]

¹¹ Cf. *Estudios sobre la histeria* (Breuer y Freud, 1895).

¹² [Sobre esto y lo que sigue, compárese el examen más amplio que hizo Freud del tema, agregando algunos comentarios críticos, en su segundo trabajo acerca de las neuropsicosis de defensa (1896b).]

sobre trece se trataba de una relación infantil por ambas partes, unas relaciones sexuales entre una niña y un varoncito un poco mayor, las más de las veces su hermano, que había sido víctima él mismo de una seducción anterior. Estas relaciones habían proseguido a veces durante años, hasta la pubertad de los pequeños culpables; el muchacho repetía siempre y sin innovación sobre la niña las mismas prácticas que a su turno había sufrido de una sirvienta o gobernanta, y que a causa de este origen eran a menudo de naturaleza repugnante. En algunos casos había concurrencia de atentado y de relación infantil, o abuso brutal reiterado.

La fecha de la experiencia precoz era variable: en dos casos la serie comenzaba en el segundo año (?)¹³ de la criatura; la edad de preferencia es en mis observaciones el cuarto o quinto año. Quizás eso se deba un poco al azar, pero de ahí extraje la impresión de que un episodio sexual pasivo que ocurra después de los ocho a diez años de edad ya no podrá echar los cimientos de esta neurosis.

¿Cómo quedar convencido de la realidad de esas confesiones de análisis que pretenden ser recuerdos conservados desde la primera infancia, y cómo prevenirse de la inclinación a mentir y la fácil inventiva atribuidas a los histéricos? Yo mismo me acusaría de condenable credulidad si no dispusiera de pruebas más concluyentes. Pero es que los enfermos jamás cuentan esas historias espontáneamente, ni en el curso del tratamiento ofrecen nunca al médico de una sola vez el recuerdo completo de una escena así. Sólo se logra despertar la huella psíquica del suceso sexual precoz bajo la más enérgica presión del procedimiento analizador y contra una resistencia enorme, y por eso es preciso arrancarle el recuerdo fragmento por fragmento, y en tanto se despierta aquel en su conciencia, ellos caen presa de una emoción difícil de falsificar.

Uno terminará por convencerse, aun si no está influido por la conducta de los enfermos, siempre que pueda seguir en detalle, en un informe, el curso de un psicoanálisis de histeria.

El acontecimiento precoz en cuestión ha dejado una impronta imperecedera en la historia del caso; está representado en él por una multitud de síntomas y de rasgos particulares que no se podrían explicar de otro modo; está regido¹⁴

¹³ [El signo de interrogación figura en el original.]

¹⁴ [«Régi» en la publicación original; en todas las reimpresiones posteriores, hasta la de 1925 inclusive, se lee «exigé» {«exigido»}, pero en 1952 se volvió a «régi». Cf. mi «Nota introductoria» a «Observaciones y fobias» (1895c), *supra*, págs. 72-3.]

de manera perentoria por el encadenamiento sutil, pero sólido, de la estructura intrínseca de la neurosis. El efecto terapéutico del análisis se demora si uno no ha penetrado tan lejos, pero, una vez que se lo ha hecho, no se tiene otra opción que refutar el todo en su conjunto o prestarle creencia.

¿Es concebible que una experiencia sexual precoz, sufrida por un individuo cuyo sexo está apenas diferenciado, se convierta en la fuente de una anomalía psíquica persistente como la histeria? ¿Y cómo concordaría esa suposición con nuestras ideas actuales sobre el mecanismo psíquico de esta neurosis? Se puede dar una respuesta satisfactoria a la primera pregunta: justamente por ser infantil el sujeto, la irritación sexual precoz produce un efecto nulo o escaso en su momento, pero se conserva su huella psíquica. Luego, cuando en la pubertad se desarrolle la reactividad de los órganos sexuales hasta un nivel casi inconmensurable con el estado infantil, de una manera u otra habrá de despertar esta huella psíquica inconciente. Merced al cambio debido a la pubertad, el recuerdo desplegará un poder que le faltó totalmente al acontecimiento mismo; *el recuerdo obrará como si fuera un acontecimiento actual*. Hay, por así decir, *acción póstuma {posthume} de un trauma sexual*.

Hasta donde yo lo veo, este despertar del recuerdo sexual después de la pubertad, tras haber sucedido el acontecimiento mismo en un tiempo remoto antes de ese período, constituye la única eventualidad psicológica para que la acción inmediata de un recuerdo sobrepase la del acontecimiento actual. Es que es esa una constelación anormal que toca un lado débil del mecanismo psíquico y produce necesariamente un efecto psíquico patológico.

Creo comprender que *esta relación inversa entre el efecto psíquico del recuerdo y el del acontecimiento* contiene la razón por la cual *el recuerdo permanece inconciente*.

Así se llega a un problema psíquico muy complejo, pero que, debidamente apreciado, promete echar viva luz algún día sobre las cuestiones más delicadas de la vida psíquica.¹⁵

Las ideas aquí expuestas, cuyo punto de partida es un resultado del psicoanálisis, a saber, que siempre se halla como causa específica de la histeria un recuerdo de experiencia sexual precoz, no concuerdan con la teoría psicológica de la neurosis propuesta por Janet ni con ninguna otra, pero

¹⁵ [El tema tratado en los cuatro últimos párrafos es reexaminado por Freud con más amplitud en una nota a pie de página del segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (1896b), *infra*, págs. 167-8, n. 12.]

armonizan perfectamente con mis propias especulaciones desarrolladas en mis trabajos sobre las «*Abwehrneurosen*» {«neurosis de defensa»},¹⁶

• Todos los acontecimientos posteriores a la pubertad, a los cuales es preciso atribuir una influencia sobre el desarrollo de la neurosis histérica y sobre la formación de sus síntomas, no son en verdad más que unas causas concurrentes, unos «agentes provocadores», como decía Charcot, para quien la herencia nerviosa ocupaba el lugar que yo reclamo para la experiencia sexual precoz. Estos agentes accesorios no están sujetos a las condiciones estrictas que pesan sobre las causas específicas; el análisis demuestra de manera irrefutable que no gozan de una influencia patógena respecto de la histeria sino en virtud de su facultad para despertar la huella psíquica inconciente del acontecimiento infantil. Y es también gracias a su conexión con la impronta patógena primaria, y aspirados por ella, como sus recuerdos devendrán inconcientes a su vez y podrán contribuir al acrecentamiento de una actividad psíquica sustraída del poder de las funciones concientes.

La neurosis de obsesiones (*Zwangsneurose*) depende de una causa específica del todo análoga a la de la histeria. También aquí se halla un acontecimiento sexual precoz ocurrido antes de la pubertad, cuyo recuerdo deviene activo durante esa época o después de ella, y las mismas puntualizaciones y razonamientos expuestos a raíz de la histeria podrán aplicarse a las observaciones de la otra neurosis (seis casos, tres de ellos puros). Hay una sola diferencia, que parece capital. Hemos descubierto en el fondo de la etiología histérica un acontecimiento sexual pasivo, una experiencia sufrida con indiferencia o con un poquitín de amargura o de espanto. En la neurosis de obsesiones se trata, por el contrario, de un acontecimiento que ha causado placer, de una agresión sexual inspirada por el deseo (en el caso del varoncito) o de una participación con goce en las relaciones sexuales (en el caso de la niña). Las ideas obsesiones, reconocidas por el análisis en su sentido íntimo, reducidas por así decir a su expresión más simple, no son otra cosa que unos *reproches que el sujeto se dirige a causa de este goce sexual anticipado*, pero unos reproches desfigurados por un trabajo psíquico inconciente de transformación y de sustitución.¹⁷

¹⁶ [Cf. Freud (1894a y 1896b).]

¹⁷ [Una caracterización análoga pero más completa se ofrece en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa (1896b), *infra*, págs. 168 y sigs.]

El hecho mismo de que tales agresiones sexuales ocurran a edad tan tierna parece denunciar el influjo de una seducción anterior, de la cual la precocidad del deseo sexual sería la consecuencia. El análisis viene a confirmar esta sospecha en los casos estudiados por mí. De esta manera, uno se explica un hecho interesante que se halla siempre presente en esos casos de obsesiones: la complicación regular del cuadro sintomático por un cierto número de síntomas simplemente histéricos.

La importancia del elemento activo de la vida sexual como causa de las obsesiones, y de la pasividad sexual para la patogénesis de la histeria, parece incluso revelar la razón del nexo más íntimo de la histeria con el sexo femenino y de la preferencia de los hombres por la neurosis de obsesiones.¹⁸ A veces uno encuentra parejas de enfermos neuróticos que han sido una pareja de pequeños amantes en su niñez temprana y de ellos el hombre sufre de obsesiones, y de histeria la mujer; si se trata de un hermano y su hermana, se podrá tomar equivocadamente por un efecto de la herencia nerviosa lo que en verdad deriva de experiencias sexuales precoces.

Hay sin duda casos de histeria o de obsesiones puros y aislados, independientes de toda neurastenia o neurosis de angustia; pero no es la regla. Más a menudo la psiconeurosis¹⁹ se presenta como accesoria a las neurosis neurasténicas, es evocada por estas y sigue sus trayectorias. Ello se debe a que las causas específicas de estas últimas, los desórdenes actuales de la vida sexual, obran al mismo tiempo como causas accesorias de las psiconeurosis, cuya causa específica, el recuerdo de la experiencia sexual precoz, ellas despiertan y reaniman.²⁰

En cuanto a la herencia nerviosa, estoy lejos de saber evaluar con justeza su influjo en la etiología de las psiconeurosis. Concedo que su presencia es indispensable en los casos graves, dudo de que sea necesaria para los casos leves, pero estoy convencido de que la herencia nerviosa por sí sola no puede producir las psiconeurosis si está ausente la

¹⁸ [Freud insistió en esto treinta años más tarde, en *Inhibición, síntoma y angustia* (1926d), *AE*, 20, pág. 135: «Sabemos con certeza que la histeria tiene mayor afinidad con la feminidad, así como la neurosis obsesiva con la masculinidad».]

¹⁹ [Primera aparición del término en una obra publicada de Freud; ya lo había utilizado en el «Proyecto de psicología» de 1895 (1950a), *AE*, 1, pág. 381.]

²⁰ [También este punto es tratado más ampliamente en «Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa» (1896b), *infra*, págs. 167-8.]

etiología específica de estas, la irritación sexual precoz. Y hasta veo que la cuestión de saber cuál de las neurosis, histeria u obsesiones, se desarrollará en un caso dado no es dirimida por la herencia, sino por un carácter especial de este acontecimiento sexual de la niñez temprana.²¹

²¹ [Freud comenzaba a interesarse por el problema de la «elección de neurosis»; cf. *ibid.*, págs. 169-70, y mi «Nota introductoria» a «La etiología de la histeria» (1896c), *infra*, pág. 188.]

Nuevas puntualizaciones sobre
las neuropsicosis de defensa
(1896)

Nota introductoria

«Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen»

Ediciones en alemán

- 1896 *Neurol. Zbl.*, **15**, nº 10, págs. 434-48. (15 de mayo.)
1906 *SKSN*, **1**, págs. 112-34. (1911, 2ª ed.; 1920, 3ª ed.; 1922, 4ª ed.)
1925 *GS*, **1**, págs. 363-87.
1952 *GW*, **1**, págs. 379-403.

*Traducciones en castellano**

- 1926(?) «Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa». *BN* (17 vols.), **11**, págs. 236-64. Traducción de Luis López-Ballesteros.
1943 Igual título. *EA*, **11**, págs. 219-44. El mismo traductor.
1948 Igual título. *BN* (2 vols.), **1**, págs. 220-31. El mismo traductor.
1953 Igual título. *SR*, **11**, págs. 175-94. El mismo traductor.
1967 Igual título. *BN* (3 vols.), **1**, págs. 219-30. El mismo traductor.
1972 Igual título. *BN* (9 vols.), **1**, págs. 288-98. El mismo traductor.

Este trabajo fue resumido por Freud bajo el número XXXV en el sumario de sus primeros escritos científicos (1897*b*), *infra*, pág. 246.

Como ya hemos explicado en la «Nota introductoria» a «La herencia y la etiología de las neurosis» (1896*a*), *supra*, pág. 141, este artículo fue enviado por Freud a su editor el

* {Cf. la «Advertencia sobre la edición en castellano», *supra*, pág. xiii y n. 6.}

mismo día que aquel (5 de febrero de 1896), pero publicado unas seis semanas después. Al incluirse en los *Gesammelte Schriften* en 1925, Freud agregó dos o tres notas a pie de página. Anteriormente había hecho un agregado sustancial en una nota de la traducción inglesa de 1924¹ (cf. *infra*, pág. 180, n. 27), pero este agregado no fue incluido en ninguna edición en alemán.

En este segundo artículo sobre las neuropsicosis de defensa, la discusión es retomada en el punto al que había llegado en el primero (1894a), dos años atrás. Muchas de las conclusiones a que aquí se arriba habían sido sumariamente anticipadas en el trabajo en francés sobre la herencia (1896a); la parte esencial del trabajo le fue comunicada unas semanas antes a Fliess en un largo documento de fecha 1º de enero de 1896, al que Freud tituló «Un cuento de Navidad» (Freud, 1950a, Manuscrito K). De igual modo que su antecesor de 1894, el presente artículo se divide en tres secciones, que tratan respectivamente la histeria, las representaciones obsesivas y los estados psicóticos, y en cada caso se nos ofrecen los resultados de dos años de ulteriores investigaciones. En el trabajo anterior, el acento ya estaba colocado en el concepto de «defensa» o «represión»; aquí se examina mucho más de cerca aquello contra lo cual se hace operar la defensa, y en todos los casos se llega a la conclusión de que el factor causante es una vivencia *sexual* de índole traumática —en la histeria una experiencia *pasiva*, en las obsesiones una *activa*, si bien incluso en este último caso hay en el trasfondo más remoto una experiencia pasiva previa—. Dicho de otro modo, la causa última es siempre la seducción de un niño por parte de un adulto. (Cf. «La etiología de la histeria» (1896c), *infra*, págs. 206-7. Además, el suceso traumático eficiente tiene lugar siempre antes del período de la pubertad, por más que el estallido de la neurosis se produzca *luego* de esta.²

Como lo demuestra una nota agregada por Freud (pág. 169, n. 15), más adelante él abandonó por entero esta posición, abandono que marca un punto de viraje de máxima importancia en sus concepciones. En una carta a Fliess del 21 de setiembre de 1897 (Freud, 1950a, Carta 69), *AE*, 1, pág. 301, le revela lo que había estado columbrando durante varios meses: era poco creíble que acciones perversas realizadas en perjuicio de niños gozaran de tanta generalidad,

¹ *Collected Papers*, Londres (5 vols.), 1, págs. 155-82.

² Estos hallazgos ya le habían sido esbozados a Fliess unos meses antes (a partir del 8 de octubre de 1895). Véase también *infra*, págs. 167-8, n. 12.

en especial teniendo en cuenta que en todos esos casos debía verse en el padre el causante de tales acciones. Pero Freud daría expresión pública a este cambio en sus opiniones sólo varios años más tarde, en «Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis» (1906a), *AE*, 7, págs. 266-7. La importante consecuencia de haber admitido esto fue, empero, que Freud pudo percatarse del papel que desempeñan las fantasías en los sucesos anímicos, lo cual le abrió la puerta para el descubrimiento de la sexualidad infantil y del complejo de Edipo. Hacemos una reseña más detallada de los cambios que sufrieron sus opiniones sobre este tema en la «Nota introductoria» a *Tres ensayos de teoría sexual* (1905d), *AE*, 7, págs. 112-6; se registra un desarrollo ulterior de esta teoría en «Sobre la sexualidad femenina» (1931b), *AE*, 21, págs. 239-40, donde las tempranas fantasías de la niña de ser seducida por su padre se reconducen a sus relaciones aún anteriores con la madre.

Señalemos, de paso, que merced al descubrimiento de la sexualidad infantil y a la admisión de la persistencia de mociones pulsionales inconcientes, perdió significatividad el problema planteado por el hecho de que el *recuerdo* de un trauma infantil pudiera tener mucho más efecto que su vivencia real en el momento de producirse dicho trauma —problema tratado repetidas veces por Freud en esta época y del que da minuciosa cuenta en la nota de págs. 167-8—.

Mayor interés todavía reviste quizás el observar la presentación, en este trabajo, de varios novedosos *mecanismos* psíquicos, que habrían de cumplir amplio cometido en las posteriores elucidaciones de Freud sobre los procesos anímicos. Particularmente notable es su detenido análisis de los mecanismos obsesivos, que anticipa gran parte de lo que quince años más tarde dio a conocer en la sección teórica del historial clínico del «Hombre de las Ratas» (1909d). De este modo, nos encontramos con tempranas alusiones a la concepción de las representaciones obsesivas como autorreproches (pág. 170), a la noción de que los síntomas son un fracaso de la defensa y un «retorno de lo reprimido» (*ibid.*), y a la teoría, de vasto alcance, según la cual los síntomas son formaciones de compromiso entre las fuerzas reprimidas y las represoras. Por último, en la sección que versa sobre la paranoia hace su primera aparición el concepto de «proyección» (pág. 183), y más adelante, hacia el final del artículo, encontramos el concepto de «alteración del yo»,³ en

³ Que ya estaba presente en el Manuscrito K de la correspondencia con Fliess (Freud, 1950a), *AE*, 1, pág. 267.

el cual es posible ver prefiguradas ideas que volverían a salir a la luz en algunos de los postreros escritos de Freud —como por ejemplo en «Análisis terminable e interminable» (1937*c*)—.

James Strachey

[Introducción]

En un breve ensayo publicado en 1894¹ he reunido la histeria, las representaciones obsesivas, así como ciertos casos de confusión alucinatoria aguda, bajo el título de «neuropsicosis de defensa», porque se había obtenido para estas afecciones un punto de vista común, a saber: ellas nacían mediante el mecanismo psíquico de la *defensa* (inconciencia), es decir, a raíz del intento de reprimir una representación inconciliable que había entrado en penosa oposición con el yo del enfermo. En algunos pasajes de un libro aparecido después, *Estudios sobre la histeria*,² que escribí en colaboración con el doctor J. Breuer, he podido elucidar e ilustrar mediante observaciones clínicas el sentido en que se ha de comprender este proceso psíquico de la «defensa» o «represión». Allí mismo se encuentran también indicaciones sobre el método del psicoanálisis,³ método arduo, pero enteramente confiable, del que me valgo en esas indagaciones que constituyen a la vez una terapia.

Pues bien: las experiencias que he tenido en los dos últimos años de trabajo me han corroborado en mi inclinación a situar la defensa en el punto nuclear dentro del mecanismo psíquico de las neurosis mencionadas, y por otra parte me han permitido dar una base clínica a la teoría psicológica. Para mi propio asombro, he hallado para los problemas de las neurosis algunas soluciones simples, pero bien circunscritas, de las que informaré de manera provisional y sucinta en las páginas que siguen. No se concilia con el modo de comunicación escogido adjuntar aquí a las tesis las pruebas que requieren; espero poder cumplir esa obligación más adelante, en una exposición de detalle.⁴

¹ [«Las neuropsicosis de defensa» (1894a).]

² [Freud (1895d).]

³ [Primera aparición del término en alemán; cf. mi «Nota introductoria» a «La herencia y la etiología de las neurosis» (1896a), *supra*, pág. 142.]

⁴ [El 16 de marzo de 1896, muy poco después de escribir esto,

I. La etiología «específica» de la histeria⁵

Que los síntomas de la histeria sólo se vuelven inteligibles reconduciéndolos a unas vivencias de eficiencia «traumática», y que estos traumas psíquicos se refieren a la vida sexual, he ahí algo que Breuer y yo hemos declarado ya en publicaciones anteriores.⁶ Lo que hoy tengo para agregar, como el resultado uniforme de los análisis, por mí realizados, de trece casos de histeria, atañe por un lado a la naturaleza de estos traumas sexuales, y por el otro al período de la vida en que ocurrieron. Para la causación de la histeria no basta que en un momento cualquiera de la vida se presente una vivencia que de alguna manera roce la vida sexual y devenga patógena por el desprendimiento y la sofocación de un afecto penoso. Antes bien, es preciso que *estos traumas sexuales correspondan a la niñez temprana {frühen Kindheit} (el período de la vida anterior a la pubertad), y su contenido tiene que consistir en una efectiva irritación de los genitales (procesos semejantes al coito).*

Hallé cumplida esta condición específica de la histeria —*pasividad sexual en períodos presexuales*— en todos los casos de histeria analizados (entre ellos, dos hombres). Apenas si hace falta indicar todo lo que disminuye, en virtud de la apuntada condicionalidad de los factores etiológicos accidentales, el reclamo de una predisposición hereditaria; además, empezamos a entender la frecuencia incomparablemente mayor de la histeria en el sexo femenino, que, en efecto, es más estimulador de ataques sexuales aun en la niñez.

Freud le informaba a Fliess (Freud, 1950a, Carta 43): «Mi labor científica avanza paulatinamente. Hoy, como un poeta en ciérne, he puesto como encabezamiento en una hoja:

*Conferencias sobre las grandes neurosis
(Neurastenia, neurosis de angustia, histeria, neurosis obsesiva)*

[...] tras lo cual asoma ya otra obra más hermosa:

Psicología y psicoterapia de las neurosis de defensa.

Pero nada habría de resultar de todo esto en lo inmediato, aparte de unas pocas conferencias inéditas y de los dos artículos que aparecen a continuación en el presente volumen (1896c y 1898a). Otras cuestiones, su autoanálisis y el problema de los sueños, pronto absorberían el interés de Freud.]

⁵ [Gran parte del material de esta sección se reproduce o amplía en «La etiología de la histeria» (1896c), *infra*, págs. 201 y sigs.]

⁶ [Cf. la «Comunicación preliminar» (1893a) y «Las neuropsicosis de defensa» (1894a).]

Las objeciones más obvias a este resultado aducirán que los ataques sexuales a niños pequeños son demasiado frecuentes para que su comprobación pudiera reclamar un valor etiológico, o que tales vivencias por fuerza carecerán de toda eficiencia por afectar a un ser no desarrollado sexualmente; además, se dirá, hay que guardarse de instilar a los enfermos, por medio del examen, esta clase de supuestas reminiscencias, o de creer en las novelas que ellos mismos inventan. A estas últimas objeciones cabe oponer el pedido de que nadie juzgue con demasiada suficiencia en estos oscuros terrenos si antes no se valió del único método capaz de iluminarlos (el psicoanálisis, para hacer consciente lo hasta entonces inconsciente).⁷ En cuanto a lo esencial de las dudas consignadas en primer término, se lo aventa con la puntualización de que no son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino sólo su reanimación como *recuerdo*, después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual.

Mis trece casos de histeria eran todos graves; llevaban varios años de duración, algunos tras largo e infructuoso tratamiento en sanatorios. Los traumas infantiles descubiertos por el análisis para estos casos graves debieron calificarse sin excepción como unos serios influjos sexuales nocivos; a veces eran cosas directamente aborrecibles. Entre las personas culpables de esos abusos de tan serias consecuencias aparecen sobre todo niñeras, gobernantas y otro personal de servicio, a quienes son entregados los niños con excesiva desaprensión; están representados además los educadores, con lamentable frecuencia;⁸ en siete de aquellos trece casos se trataba, empero, de unos atentados infantiles no culposos, las más de las veces por hermanos varones que durante años habían mantenido relaciones sexuales con sus hermanas un poco menores. En todos los casos el proceso fue quizá semejante al que se averiguó con certeza en algunos, a saber: el muchacho había sufrido abusos de una per-

⁷ Hasta conjeturo que las tan frecuentes invenciones {*Dichtung*, también «creaciones poéticas»} de atentados a que suelen entregarse las histéricas son unos inventos compulsivos que parten de la huella mnémica del trauma infantil.

⁸ [Cabe destacar que en este trabajo Freud no menciona el hecho de que en el caso de las pacientes femeninas el presunto seductor era a menudo el padre, como lo indicó en su carta a Fliess citada en mi «Nota introductoria», *supra*, pág. 160. En dos notas agregadas en 1924 a *Estudios sobre la histeria* (1895d), Freud admitió que en dos de los casos sobre los que allí se informa ocultó este hecho {atribuyendo el atentado no al padre sino al tío de la enferma} (*AE*, 2, págs. 150 y 183).]

sona del sexo temenino, lo cual le despertó prematuramente la libido, y años después, en una agresión sexual contra su hermana, repitió exactamente los mismos procedimientos a que lo habían sometido a él.

De la lista de las nocividades sexuales de la niñez temprana patógenas para la histeria, es preciso excluir una masturbación activa. Si, no obstante, tan a menudo se la encuentra junto a la histeria, ello se debe a la circunstancia de que la masturbación misma es, con frecuencia mucho mayor de lo que se cree, el resultado del abuso o de la seducción. No es raro que las dos partes de la pareja infantil contraigan luego neurosis de defensa: el hermano, unas representaciones obsesivas; la hermana, una histeria; y ello desde luego muestra la apariencia de una predisposición neurótica familiar. Esta pseudoherencia se resuelve a veces, sin embargo, de una manera sorprendente; en una de mis observaciones, un hermano, una hermana y un primo algo mayor estaban enfermos. Por el análisis que emprendí con el hermano, me enteré de que sufría de unos reproches por ser el culpable de la enfermedad de la hermana; a él mismo lo había seducido el primo, y de este se sabía en la familia que había sido víctima de su niñera.

No puedo indicar con seguridad el límite máximo de edad hasta el cual un influjo sexual nocivo entra en la etiología de la histeria; dudo, sin embargo, de que una pasividad sexual después del octavo año, y hasta el décimo,⁹ pueda posibilitar una represión si esta última no es promovida por una vivencia anterior. En cuanto al límite inferior, llega hasta donde alcanza el recuerdo, vale decir, ¡hasta la tierna edad de un año y medio, o dos años! (dos casos). En algunos de mis casos, el trauma sexual (o la serie de traumas) está contenido dentro del tercero y el cuarto año de vida. Yo mismo no daría crédito a estos peregrinos descubrimientos si ellos no se volvieran cabalmente confiables por la plasmación de la posterior neurosis. En cada caso, toda una suma de síntomas patológicos, hábitos y fobias sólo es explicable si uno se remonta a aquellas vivencias infantiles, y la ensambladura lógica de las exteriorizaciones neuróticas vuelve imposible desautorizar esos recuerdos que afloran desde el vivenciar infantil y se han conservado fielmente. Desde luego que en vano se pretendería inquirir a un histérico por estos traumas de la infancia fuera del psicoanálisis; su huella nunca se descubre en el recordar conciente, sino sólo en los síntomas de la enfermedad.

⁹ [Véase mi agregado al final de la nota 12 de pág. 168.]

Todas las vivencias y excitaciones que preparan u ocasionan el estallido de la histeria en el período de la vida posterior a la pubertad sólo ejercen su efecto, *comprobablemente*, por despertar la huella mnémica de esos traumas de la infancia, huella que no deviene entonces conciente, sino que conduce al desprendimiento de afecto y a la represión. Armoniza muy bien con este papel de los traumas posteriores el hecho de que no estén sujetos al estricto condicionamiento de los traumas infantiles, sino que puedan variar en intensidad y naturaleza desde un avasallamiento sexual efectivo hasta unos meros acercamientos sexuales, y hasta la percepción sensorial de actos sexuales en terceros o el recibir comunicaciones sobre procesos genésicos.¹⁰

En mi primera comunicación sobre las neurosis de defensa¹¹ quedó sin esclarecer cómo el afán de la persona hasta ese momento sana por olvidar una de aquellas vivencias traumáticas podía tener por resultado que se alcanzara realmente la represión deliberada y, con ello, se abriesen las puertas a la neurosis de defensa. Ello no podía deberse a la naturaleza de la vivencia, pues otras personas permanecían sanas a despecho de idénticas ocasiones. No era posible entonces explicar cabalmente la histeria a partir del efecto del trauma; debía admitirse que la aptitud para la reacción histérica existía ya antes de este.

Ahora bien, tal predisposición histérica indeterminada puede remplazarse enteramente o en parte por el efecto póstumo {*posthume*} del trauma infantil sexual. Sólo consiguen «reprimir» el recuerdo de una vivencia sexual penosa de la edad madura aquellas personas en quienes esa vivencia es capaz de poner en vigor la huella mnémica de un trauma infantil.¹²

¹⁰ En un ensayo sobre la neurosis de angustia [(1895*b*), *supra*, pág. 100], mencioné que «un primer encuentro con el problema sexual (...) puede provocar en niñas adolescentes una neurosis de angustia que de manera casi típica se combina con una histeria». Hoy sé que la ocasión a raíz de la cual estalla esa *angustia virginal* no corresponde precisamente al *primer* encuentro con la sexualidad, sino que en esas personas le precedió una vivencia sexual pasiva en la infancia, cuyo recuerdo fue despertado a raíz del «primer encuentro».

¹¹ [Freud (1894*a*).]

¹² Una teoría psicológica de la represión tendría que explicar también por qué sólo representaciones de contenido sexual pueden ser reprimidas. Le sería lícito partir de las siguientes indicaciones: El representar de contenido sexual, como es sabido, produce en los genitales unos procesos de excitación semejantes a los que provoca el vivenciar sexual mismo. Cabe suponer que esta excitación somática se traspone en psíquica. Por regla general, el efecto en cuestión es mucho más intenso a raíz de la vivencia que a raíz del recuerdo de

Las representaciones obsesivas tienen de igual modo por premisa una vivencia sexual infantil (pero de otra naturaleza que en la histeria). La etiología de las dos neuropsicosis de defensa presenta el siguiente nexo con la etiología de las dos neurosis simples,¹³ la neurastenia y la neurosis de angustia. Estas dos últimas son efectos inmediatos de las noxas sexuales mismas, según lo expuse en 1895 en un ensayo sobre la neurosis de angustia;¹⁴ y las dos neurosis de defensa son consecuencias mediatas de influjos nocivos sexuales que sobrevinieron antes del ingreso en la madurez sexual, o sea, consecuencias de las huellas mnémicas psíquicas de estas noxas. Las causas actuales productoras de neurastenia y neurosis de angustia desempeñan a menudo, simultáneamente, el papel de causas suscitadoras de las neurosis de defensa; por otro lado, las causas específicas de la neurosis de defen-

ella; pero si la vivencia sexual cae en la época de la inmadurez sexual, y el recuerdo de ella es despertado durante la madurez o luego de esta, el recuerdo ejerce un efecto excitador incomparablemente mayor del que en su tiempo produjo la vivencia, pues entretanto la pubertad ha acrecentado en medida inconmensurable la capacidad de reacción del aparato sexual. Ahora bien, esta proporción inversa entre vivencia real y recuerdo parece contener la condición psicológica de una represión. La vida sexual ofrece —por el retardo de la madurez puberal respecto de las funciones psíquicas— la única posibilidad que se presenta para esa inversión de la eficiencia relativa. *Los traumas infantiles producen efectos retardados {nachträglich} como vivencias frescas, pero entonces los producen inconcientemente.* Tendré que posponer para otra ocasión unas elucidaciones psicológicas más extensas. — Señalo, además, que aquí el período de «maduración sexual» que entra en cuenta no coincide con la pubertad, sino que es anterior a ella (del octavo al décimo año). [Freud suministró un ejemplo del efecto retardado de los traumas tempranos en su análisis de «Katharina», en *Estudios sobre la histeria* (1895d), AE, 2, págs. 148-9. Había examinado extensamente esta cuestión en su «Proyecto de psicología» de 1895 (1950a), AE, 1, págs. 403-4 y 406-7; volvió a mencionarla en «La herencia y la etiología de las neurosis» (1896a), *supra*, págs. 152-3, y la discutió con mayor amplitud en «La etiología de la histeria» (1896c), *infra*, pág. 210, así como en varias cartas a Fliess de esta época; por ejemplo, en las del 1º de marzo, el 30 de mayo y el 6 de diciembre de 1896 (Cartas 42, 46 y 52), AE, 1, págs. 270-1 y 276-7. En el pasaje de *infra*, pág. 210, se vincula la edad de ocho a diez años, mencionada aquí y en otros lugares (p. ej., en pág. 166), con el período de la segunda dentición. A la sazón, Freud asignaba cierta especial importancia al papel que ese período cumplía en el desarrollo sexual, y en el curso de estos textos se alude a él en repetidas oportunidades. En las cartas a Fliess que acabamos de mencionar se encuentran algunas detalladas tablas cronológicas sobre la edad en que se producen los traumas y la represión, y sobre el problema conexo de la «elección de neurosis». Cf. mi «Nota introductoria», *supra*, pág. 161.]

¹³ [O sea, las «neurosis actuales»; cf. «La sexualidad en la etiología de las neurosis» (1898a), *infra*, pág. 271, n. 12.]

¹⁴ Freud (1895b).

sa, los traumas infantiles, establecen al mismo tiempo el fundamento para la neurastenia que se desarrollará luego. Por último, tampoco es raro el caso de que una neurastenia o una neurosis de angustia no sean mantenidas por influjos nocivos sexuales actuales, sino sólo por el continuado recuerdo de traumas infantiles.¹⁵

II. Naturaleza y mecanismo de la neurosis obsesiva

En la etiología de la neurosis obsesiva, unas vivencias sexuales de la primera infancia poseen la misma significatividad que en la histeria; empero, ya no se trata aquí de una pasividad sexual, sino de unas agresiones ejecutadas con placer y de una participación, que se sintió placentera, en actos sexuales; vale decir, se trata de una actividad sexual. A esta diferencia en las constelaciones etiológicas se debe que la neurosis obsesiva parezca preferir al sexo masculino.

Por lo demás, en todos mis casos de neurosis obsesiva he hallado un *trasfondo de síntomas histéricos*¹⁶ que se dejan reconducir a una escena de pasividad sexual anterior a la acción placentera. Conjeturo que esta conjugación es acorde a ley, y que una agresión sexual prematura presupone siempre una vivencia de seducción. Todavía no puedo, sin embargo, proporcionar una exposición acabada de la etiología de la neurosis obsesiva; sólo tengo una impresión: la decisión de que sobre la base de los traumas de la infancia se genere una histeria o una neurosis obsesiva parece entramada con las constelaciones *temporales* del desarrollo de la libido. [Cf. pág. 168, final de *n.* 12.]

La naturaleza de la neurosis obsesiva admite ser expre-

¹⁵ [Nota agregada en 1924:] Esta sección está bajo el imperio de un error que después he admitido y rectificado repetidas veces. Por aquel tiempo yo aún no sabía distinguir entre las fantasías de los analizados acerca de su infancia y unos recuerdos reales. A consecuencia de ello, atribuí al factor etiológico de la seducción una sustantividad y una validez universal que no posee. Superado este error, se abrió el panorama de las exteriorizaciones espontáneas de la sexualidad infantil, que describí en *Tres ensayos de teoría sexual* (1905d). Sin embargo, no todo lo contenido en este texto es desestimable; la seducción conserva cierta significatividad para la etiología, y todavía hoy considero acertados muchos de los desarrollos psicológicos aquí expuestos.

¹⁶ [Freud dio un ejemplo de ello mucho después, en el historial clínico del «Hombre de los Lobos» (1918b), *AE*, 17, pág. 70, y volvió a hacer un comentario de esta índole en *Inhibición, síntoma y angustia* (1926d), *AE*, 20, pág. 108.]

sada en una fórmula simple: las *representaciones obsesivas* son siempre *reproches* mudados, que retornan de la *represión* {desalojo} y están referidos siempre a una acción de la *infancia*, una acción *sexual* realizada con placer.¹⁷ Para elucidar esta tesis es necesario describir la trayectoria típica de una neurosis obsesiva.

En un primer período —período de la inmoralidad infantil—, ocurren los sucesos que contienen el germen de la neurosis posterior. Ante todo, en la más temprana infancia, las vivencias de seducción sexual que luego posibilitan la represión; y después las acciones de agresión sexual contra el otro sexo, que más tarde aparecen bajo la forma de acciones-reproche.

Pone término a este período el ingreso —a menudo anticipado— en la maduración sexual. Ahora, al recuerdo de aquellas acciones placenteras se anuda un reproche, y el nexo con la vivencia inicial de pasividad posibilita [pág. 167] —con frecuencia sólo tras un empeño conciente y recordado— reprimir ese reproche y sustituirlo por un *síntoma defensivo primario*. Escrupulos de la conciencia moral, vergüenza, desconfianza de sí mismo, son esos síntomas, con los cuales empieza el tercer período, de la salud aparente, pero, en verdad, de la defensa lograda.

El período siguiente, el de la enfermedad, se singulariza por el *retorno de los recuerdos reprimidos*, vale decir, por el fracaso de la defensa; acerca de esto, es incierto si el despertar de esos recuerdos sobreviene más a menudo de manera casual y espontánea, o a consecuencia de unas perturbaciones sexuales actuales, por así decir como efecto colateral de estas últimas. Ahora bien, los recuerdos reanimados y los reproches formados desde ellos nunca ingresan inalterados en la conciencia; lo que deviene conciente como representación y afecto obsesivos, sustituyendo al recuerdo patógeno en el vivir conciente, son unas *formaciones de compromiso* entre las representaciones reprimidas y las represoras.¹⁸

Para describir de una manera intuible y con acierto probable los procesos de la represión, del retorno de lo reprimido¹⁹ y la formación de representaciones patológicas de compromiso, uno tendría que decidirse por unos muy precisos supuestos sobre el sustrato del acontecer psíquico y de

¹⁷ [Esta definición fue sometida a una revisión crítica en el historial clínico del «Hombre de las Ratras» (1909d), AE, 10, pág. 173.]

¹⁸ [La última oración fue citada, asimismo, en una nota al pie en el mencionado pasaje del historial del «Hombre de las Ratras».]

¹⁹ [Primera vez que aparece esta expresión.]

la conciencia.²⁰ Mientras se los quiera evitar, habrá que limitarse a las siguientes puntualizaciones, entendidas más bien figuradamente: Existen dos formas de la neurosis obsesiva, según que se conquiste el ingreso a la conciencia sólo el contenido mnémico de la acción-reproche, o también el afecto-reproche a ella anudado. El primer caso es el de las representaciones obsesivas típicas, en que el contenido atrae sobre sí la atención del enfermo y como afecto se siente sólo un displacer impreciso, en tanto que al contenido de la representación obsesiva sólo convendría el afecto del reproche. El contenido de la representación obsesiva está doblemente desfigurado respecto del que tuvo la acción obsesiva en la infancia: en primer lugar, porque algo actual remplace a lo pasado, y, en segundo lugar, porque lo sexual está sustituido por un análogo no sexual. Estas dos modificaciones son el efecto de la inclinación represiva que continúa vigente, y que atribuiremos al «yo». El influjo del recuerdo patógeno reanimado se muestra en que el contenido de la representación obsesiva sigue siendo fragmentariamente idéntico a lo reprimido o se deriva de esto por medio de una correcta secuencia de pensamiento. Si uno reconstruye, con ayuda del método psicoanalítico, la génesis de cada representación obsesiva, halla que desde una impresión actual han sido incitadas dos diversas ilaciones de pensamiento; de ellas, la que ha pasado por el recuerdo reprimido demuestra estar formada tan correctamente desde el punto de vista lógico como la otra, no obstante ser insusceptible de conciencia e incorregible. Si los resultados de las dos operaciones psíquicas no concuerdan, esto no conduce, por ejemplo, a la nivelación lógica de la contradicción entre ambas, sino que en la conciencia entra, junto al resultado del pensar normal, y como un compromiso entre la resistencia y el resultado del pensar patológico, una representación obsesiva que parece absurda. Y si las dos ilaciones de pensamiento llevan a la misma conclusión, se refuerzan entre sí, de suerte que un resultado del pensar adquirido por vía normal se comporta ahora, psicológicamente, como una representación obsesiva. *Toda vez que una obsesión neurótica aparece en lo psíquico, ella proviene de una represión.* Las representaciones obsesivas {*Zwangsvorstellung*} no tienen, por así decir, curso psíquico forzoso {*Zwangskurs*} a causa de su valor intrínseco, sino por el de la fuente de que provienen o que ha contribuido a su vigencia.

²⁰ [Otro indicio del interés de Freud por el problema de los procesos psíquicos inconcientes; cf. «Las neuropsicosis de defensa» (1894a), *supra*, pág. 54.]